ANEXO

FÉ DE ERRATAS

Guía de Práctica Clínica para el Tamizaje de Cáncer de Mama en el Primer Nivel de Atención
Guía en Versión Extensa

DICE:

V DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS Y RECOMENDACIONES

(...)

V.5 Pregunta 5. En mujeres asintomáticas de 40 a 69 años con alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, ¿se debería usar resonancia magnética adicional a la mamografía en lugar de solo mamografía para el tamizaje del cáncer de mama?

(...)

Recomendación y justificación:

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	***Recomendación***
Dirección: *el GEG consideró que debido a que la magnitud de los efectos es moderada y los efectos indeseables triviales, el balance probablemente favorecería a la intervención. A pesar de que los costos serían moderados, recomendar esta intervención probablemente incrementaría la equidad, sería probablemente factible y aceptable. Por ende, el GEG decide emitir una recomendación* ***a favor****.* ***Fuerza:*** *debido a que la certeza de la evidencia es muy baja, se emite una recomendación condicional.* *El GEG consideró importante señalar la periodicidad de esta intervención. Siguiendo las recomendaciones de otras guías (51) para mujeres con alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, el GEG sugirió que esta intervención debe realizarse de manera anual. Asimismo, se realizó una revisión de guías internacionales y sus definiciones de alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, eligiéndose seguir la definición de mujer de alto riesgo señalada por la GPC de Colombia de 2017 (52). Adicionalmente, el GEG decidió añadir un flujograma para orientar la elección del modelo a seguir para calcular el riesgo de desarrollar cáncer de mama basándose en la RS de Amir et al 2017 que tuvo como objetivo revisar todos los modelos disponibles para el cálculo de este riesgo y orientar la decisión entre ellos.*	*En mujeres asintomáticas de 40 a 69 años con alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, se sugiere realizar resonancia magnética con contraste adicional a la mamografía como tamizaje de cáncer de mama.* ***Recomendación condicional en contra*** ***Certeza de la evidencia: baja*** ⊕⊕◯◯ <u>Consideraciones adicionales</u>: • *Esta recomendación debería ser implementada con una frecuencia anual.* • *Esta recomendación está dirigida a mujeres con alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, es decir las mujeres que presenten al menos uno de los siguientes antecedentes:* • *Portadora de mutación genética conocida que aumenta el riesgo de cáncer de mama: BRCA1, BRCA2, PTEN, síndrome de Li Fraumeni, etc.* • *Mujer con antecedente familiar en primer grado de mutación genética conocida (riesgo del 50% de ser portadora de la mutación genética)* • *Antecedente de radioterapia sobre la pared del tórax a una edad menor de 30 años.* • *Riesgo en el transcurso de la vida >30%, estimado por alguno de los modelos existentes para evaluar riesgo de cáncer de mama: IBIS, Gail, BOADICEA (Ver Flujograma 2)*

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD · SUBDIRECCIÓN DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA · CENTRO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD

DEBE DECIR:

V DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS Y RECOMENDACIONES

(...)

V.5 Pregunta 5. En mujeres asintomáticas de 40 a 69 años con alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, ¿se debería usar resonancia magnética adicional a la mamografía en lugar de solo mamografía para el tamizaje del cáncer de mama?

(...)

Recomendación y justificación:

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	***Recomendación***
Dirección: *el GEG consideró que debido a que la magnitud de los efectos es moderada y los efectos indeseables triviales, el balance probablemente favorecería a la intervención. A pesar de que los costos serían moderados, recomendar esta intervención probablemente incrementaría la equidad, sería probablemente factible y aceptable. Por ende, el GEG decide emitir una recomendación* ***a favor****.* ***Fuerza:*** *debido a que la certeza de la evidencia es muy baja, se emite una recomendación condicional.* *El GEG consideró importante señalar la periodicidad de esta intervención. Siguiendo las recomendaciones de otras guías (51) para mujeres con alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, el GEG sugirió que esta intervención debe realizarse de manera anual. Asimismo, se realizó una revisión de guías internacionales y sus definiciones de alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, eligiéndose seguir la definición de mujer de alto riesgo señalada por la GPC de Colombia de 2017 (52). Adicionalmente, el GEG decidió añadir un flujograma para orientar la elección del modelo a seguir para calcular el riesgo de desarrollar cáncer de mama basándose en la RS de Amir et al 2017 que tuvo como objetivo revisar todos los modelos disponibles para el cálculo de este riesgo y orientar la decisión entre ellos.*	*En mujeres asintomáticas de 40 a 69 años con alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, se sugiere realizar resonancia magnética con contraste adicional a la mamografía como tamizaje de cáncer de mama.* ***Recomendación condicional a favor*** ***Certeza de la evidencia: baja*** ⊕⊕◯◯ *Consideraciones adicionales:* • *Esta recomendación debería ser implementada con una frecuencia anual.* • *Esta recomendación está dirigida a mujeres con alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, es decir las mujeres que presenten al menos uno de los siguientes antecedentes:* • *Portadora de mutación genética conocida que aumenta el riesgo de cáncer de mama: BRCA1, BRCA2, PTEN, síndrome de Li Fraumeni, etc.* • *Mujer con antecedente familiar en primer grado de mutación genética conocida (riesgo del 50% de ser portadora de la mutación genética)* • *Antecedente de radioterapia sobre la pared del tórax a una edad menor de 30 años.* • *Riesgo en el transcurso de la vida >30%, estimado por alguno de los modelos existentes para evaluar riesgo de cáncer de mama: IBIS, Gail, BOADICEA (Ver Flujograma 2)*

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - CENTRO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD - SUBDIRECCIÓN DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA